

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

EVALUACIÓN CONDUCTUAL DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA - 2ª EDICIÓN (BRIEF-2)

Eje V: Neurocognición y Funciones Ejecutivas • Evaluación Ecológica en Entornos Cotidianos de Gioia e Isquith

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva, Segunda Edición (BRIEF-2).
Nombre Original	Behavior Rating Inventory of Executive Function, Second Edition (BRIEF-2; Gioia et al., 2015).
Autores Originales	Gerard A. Gioia, Ph.D., Peter K. Isquith, Ph.D., Steven C. Guy, Ph.D. y Lauren Kenworthy, Ph.D.
Adaptación Hispana	Maldonado, Peña-Casanova, et al. (TEA Ediciones, 2017); estandarización en España y LatAm.
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Manifestaciones conductuales cotidianas de la disfunción ejecutiva.
Tipo de Instrumento	Batería de cuestionarios estandarizados multimétodo (Familia, Escuela y Autoinforme).
Composición de Ítems	63 ítems en cuestionarios de Familia y Escuela; 55 ítems en versión de Autoinforme.
Población y Rango	Niños y adolescentes de 5 a 18 años (Familia/Escuela) y de 11 a 18 años (Autoinforme).
Tiempo de Administración	10 a 15 minutos por cuestionario; corrección informatizada o manual por plantilla.
Régimen de Licencia	PAR Inc. (Psychological Assessment Resources) / Distribución en español por TEA Ediciones.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO ECOLÓGICO DE REGULACIÓN EJECUTIVA

El **BRIEF-2** parte de la premisa de que los tests neuropsicológicos estructurados en consulta (como Wisconsin o Stroop) no capturan plenamente las fallas de autorregulación en situaciones abiertas, multifacéticas y dinámicas de la vida real:

1. **Validez Ecológica Superior:** Evalúa cómo operan los procesos ejecutivos en el hogar y la escuela, donde el individuo debe iniciar actividades, gestionar emociones y resolver imprevistos sin la supervisión estructurada de un evaluador.
2. **Modelo Tripartito de Regulación:** Estructura las funciones ejecutivas en tres ejes interdependientes: Regulación Conductual (freno e inhibición motriz/social), Regulación Emocional (flexibilidad ante la frustración) y Regulación Cognitiva (planificación y memoria operativa).
3. **Triangulación Multifuente:** Permite comparar objetivamente las percepciones de padres, maestros y del propio joven, identificando discrepancias situacionales cruciales para el diagnóstico de TDAH, TEA y daño cerebral adquirido.

3. ESTRUCTURA FACTORIAL, ÍNDICES Y ESCALAS CLÍNICAS

Índice / Dimensión	Escalas Clínicas	Definición Operativa del Constructo Neuropsicológico
Regulación Conductual (IRC)	Inhibición Automonitorización	Control de impulsos, frenado de conductas prepotentes y conciencia del propio impacto social.
Regulación Emocional (IRE)	Flexibilidad Control Emocional	Adaptación activa ante cambios imprevistos y modulación afectiva ante la frustración o estrés.
Regulación Cognitiva (IRCog)	Iniciativa Memoria de Trabajo Planificación Supervisión Materiales	Habilidad para comenzar tareas de forma autónoma, retener información operativa, estructurar pasos anticipados, corregir errores en la marcha y mantener el orden físico.
Índice Global (IGFE / GEC)	Puntuación Compuesta	Resumen global integrado de la eficacia funcional ejecutiva en la vida cotidiana.
Escalas de Validez	Inconsistencia Negatividad Infrecuencia	Detección de patrones de respuesta aleatorios, sesgos acusadamente desfavorables o respuestas inverosímiles.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

La adaptación española (Maldonado et al., TEA Ediciones, 2017; $N > 1800$) demuestra robustez psicométrica en población clínica y general:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Global	Alfa de Cronbach = 0.92 - 0.97	Excelente homogeneidad estructural en el IGFE y los tres índices centrales.
Fiabilidad de Subescalas	Alfa de Cronbach = 0.76 - 0.91	Solidez métrica en todas las escalas clínicas individuales (Familia y Escuela).
Estabilidad Test-Retest	Coefficiente $r = 0.82 - 0.89$	Alta replicabilidad de puntuaciones a 3 semanas en informantes estables.
Sensibilidad en TDAH	Sensibilidad = 88% - 93%	Elevaciones selectivas en IRC e IRCog diferencian TDAH combinado e inatento.
Validez Discriminante	Efecto $d = 1.10 - 1.65$	Diferenciación neta entre población normativa y grupos clínicos con TDAH, TEA y TCE.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN PUNTUACIONES T

- **Opciones de Respuesta:** Cada ítem se califica en escala de tres opciones: 1 = Nunca (N), 2 = A veces (A), 3 = Frecuentemente (F).
- **Cálculo de Puntuaciones Directas:** Se suman los ítems constitutivos de cada escala clínica.
- **Conversión a Puntuaciones T:** Las puntuaciones directas se convierten a Puntuaciones T normalizadas ($M = 50$, $DE = 10$) según baremos diferenciados por edad, sexo e informante (Familia, Escuela, Autoinforme).
- **Direccionalidad Clínica:** A mayor puntuación T, mayor disfunción ejecutiva cotidiana percibida. Puntuaciones elevadas reflejan patología.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Rango Puntuación T	Percentil Aprox.	Significación Clínica y Nivel de Compromiso
Típico / Normal	$T < 60$	$P < 84$	Funcionamiento ejecutivo adecuado sin impacto clínico significativo.
Límite / Riesgo	$T = 60$ a 64	$P = 84$ a 92	Riesgo subclínico de desregulación; amerita monitorización educativa y familiar.
Elevación Moderada	$T = 65$ a 69	$P = 93$ a 97	Punto de corte clínico estándar disfunción ejecutiva manifiesta en el entorno.
Elevación Significativa	$T = 70$ a 79	$P = 98$ a 99	Alteración ejecutiva severa; repercusión acusada en el rendimiento académico y social.
Elevación Extrema	$T \geq 80$	$P > 99$	Disfunción ejecutiva profunda; incapacidad notable de autorregulación autónoma.

PUNTO DE CORTE CLÍNICO CRÍTICO (PUNTUACIÓN $T \geq 65$):

El umbral de $T \geq 65$ (1.5 desviaciones típicas sobre la media) constituye el criterio empírico de significación clínica para indicar disfunción ejecutiva en contextos ecológicos. Niveles $T \geq 70$ (2 desviaciones típicas) reflejan una afectación funcional severa que exige adaptaciones educativas formales e intervención neurocognitiva.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN DIAGNÓSTICA EN TRANSTORNOS DEL NEURODESARROLLO

PROTOCOLO MULTIFUENTE CON BRIEF-2 EN CONTEXTO ESCOLAR Y CLÍNICO:

- **Paso 1 (Administración Paralela):** Aplicar simultáneamente las formas de Familia y Escuela (y Autoinforme si la edad es ≥ 11 años); verificar escalas de validez (Inconsistencia < 7 , Negatividad e Infrecuencia no elevadas).
- **Paso 2 (Análisis de Perfiles Específicos):**
 - **Perfil TDAH Subtipo Combinado:** Elevación clínica combinada en IRC ($T \geq 65$, Inhibición alterada) y en IRCog ($T \geq 65$, Memoria de trabajo y Planificación descompensadas).
 - **Perfil TDAH Subtipo Inatento:** IRC conservado ($T < 60$), con afectación selectiva y acusada en IRCog ($T \geq 68$ en Memoria de Trabajo y Organización de Materiales).
 - **Perfil Trastorno del Espectro Autista (TEA):** Afectación prominente en el Índice de Regulación Emocional (IRE; Flexibilidad $T \geq 70$).
- **Paso 3 (Intervención y Adaptaciones):** Diseñar apoyos ambientales según el índice alterado (agendas visuales, fraccionamiento de metas y pautas conductuales en el aula).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DIFERENCIACIÓN ECOLÓGICA DE TDAH INATENTO

Identificación: Adolescente de 13 años cursando 2º de Educación Secundaria Obligatoria, derivado por bajo rendimiento escolar progresivo, olvido recurrente de tareas y desorganización extrema con su material lectivo, pese a poseer un CI total de 115 en WISC-V.

Evaluación BRIEF-2 (Formas Familia y Escuela coincidentes):

- **Índice Global (IGFE):** $T = 68$ (clínicamente significativo; percentil 96).
- **Regulación Conductual (IRC):** $T = 51$ (normal; Inhibición = 49, Automonitorización = 53; no presenta impulsividad ni hiperactividad motriz).
- **Regulación Emocional (IRE):** $T = 55$ (normal; Flexibilidad = 54, Control Emocional = 56).
- **Regulación Cognitiva (IRCog):** $T = 74$ (afectación severa; Memoria de Trabajo $T = 76$, Planificación/Organización $T = 73$, Organización de Materiales $T = 78$).

Juicio Diagnóstico: Patrón ecológico inequívoco de TDAH de presentación predominantemente inatenta con disfunción ejecutiva metacognitiva severa.

Intervención: Implementación de apoyos visuales escolares, división de consignas en subtarefas con tiempos definidos, uso supervisado de agenda digital y entrenamiento metacognitivo en estrategias de estudio.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DISCREPANCIA ENTRE CONTEXTOS:

Diferencias marcadas (> 15 puntos T) entre escuela y hogar señalan factores situacionales o reactivos, no disfunción ejecutiva neurobiológica primaria.

DISOCIACIÓN TEST VS. CONDUCTA:

Un rendimiento óptimo en tests de laboratorio (WCST/Stroop) no excluye disfunción ecológica; el BRIEF-2 detecta el colapso funcional en vida libre.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C., & Kenworthy, L. (2015). *Behavior Rating Inventory of Executive Function, Second Edition (BRIEF-2)*. Psychological Assessment Resources.
2. Maldonado, A., Peña-Casanova, J., et al. (2017). *BRIEF-2: Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva (Manual de adaptación española)*. TEA Ediciones.
3. Bausela-Herreras, E. (2014). Funciones ejecutivas: nociones del desarrollo desde una perspectiva neuropsicológica. *Acción Psicológica*, 11(1), 21-34.
4. Kenworthy, L., et al. (2008). Investigation of executive function in autism spectrum disorders using the BRIEF. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 38(1), 142-154.